



PROTOCOLO — PRONTO-SOCORRO NATAL DIEGUES

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi / SP • Secretaria Municipal de Saúde

Série de protocolos institucionais de urgência e emergência — uso interno da equipe médica

Protocolo 25 — Síncope e Perda Transitória de Consciência no PS

Diferenciação (síncope × crise × queda × psicogênica), causas reflexa / hipotensão ortostática / cardíaca, estratificação de risco (critérios ESC, Canadian Syncope Risk Score), ECG que não pode passar, quem vai para casa e quem é transferido — cenário: PS sem cardiologia

Código	PS-ND-25	Versão	1.0 (minuta)
Elaboração	Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986	Data-base	setembro/2026
Aprovação (Diretor Clínico)	_____	Vigência	___/___/___
Aprovação (Coordenação PS)	_____	Revisão prevista	___/___/___

0. Escopo, premissas e fontes

Síncope responde por 1–3% dos atendimentos do PS. A maioria é benigna (reflexa) e recebe exames demais; a minoria é cardíaca e, não reconhecida, precede a morte súbita. O PS não precisa fechar o diagnóstico: precisa responder **"esta síncope tem causa cardíaca provável ou risco de evento grave nos próximos 7-30 dias?"** — com anamnese, exame, PA ortostática e um ECG bem lido. O objetivo é evitar tanto a internação de todo idoso que desmaiou quanto a alta do jovem com QT longo.

Fontes de ancoragem: Brignole M, Moya A, de Lange FJ, et al. 2018 ESC Guidelines for the diagnosis and management of syncope. Eur Heart J 2018;39:1883 [ESC 2018]; Shen WK, Sheldon RS, Benditt DG, et al. 2017 ACC/AHA/HRS Guideline for the evaluation and management of patients with syncope. Circulation 2017;136:e60 [ACC 2017]; Thiruganasambandamoorthy V, et al. Canadian Syncope Risk Score — derivação (CMAJ 2016;188:E289) e validação multicêntrica (JAMA Intern Med 2020;180:737) [CSRS]; Sociedade Brasileira de Cardiologia / SOBRAC. *Diretrizes brasileiras de síncope* (edição vigente) [SBC/SOBRAC — VERIFICAR edição]; du Fay de Lavallaz J, et al. (BASEL IX) — troponina/BNP na síncope; Sandhu RK, Sheldon RS. Syncope in the emergency department. Front Cardiovasc Med 2019.

Convenção de confiança: critérios e escores conforme ESC 2018/CSRS; **[VERIFICAR]:** troponina/BNP, monitor de observação por 6–24 h, acesso a ecocardiograma/Holter/teste de inclinação na referência (Tabajara Ramos), fluxo de contrarreferência.

1. Queixa — como o paciente chega

"Desmaiei", "apaguei por alguns segundos", "caí e não lembro", "escureceu a vista e acordei no chão". Trazido por familiar/SAMU com relato de terceiros — **a testemunha é o exame mais importante:** pedir para ligar para quem viu. A anamnese estruturada responde a cinco perguntas: (1) foi perda de consciência **completa, transitória, com recuperação espontânea e completa?** (2) o que estava fazendo e em que posição? (3) houve pródromo (e qual)? (4) como foi o episódio (duração, movimentos, cor, respiração)? (5) como foi a recuperação (imediata × confusão prolongada)?

Anamnese dirigida — o que diferencia [ESC 2018, Tabela 3]

Favorece síncope REFLEXA (vasovagal/situacional)	Favorece HIPOTENSÃO ORTOSTÁTICA	Favorece causa CARDÍACA (alto risco)
- História longa de episódios semelhantes desde jovem - Gatilho: dor, medo, sangue, calor, ambiente cheio, ficar em pé muito tempo, após refeição - Situacional: micção, defecação, tosse, deglutição, riso, pós-exercício Pródromo: náusea, sudorese, calor, palidez, visão turva ("túnel") - Recuperação rápida com cansaço/náusea residual - Ausência de cardiopatia; ECG normal	- Ao levantar-se (segundos a minutos após ficar em pé) - Início/aumento recente de anti-hipertensivo, diurético, alfa-bloqueador, antidepressivo, antiparkinsoniano, nitrato - Desidratação, sangramento (melena?), diarreia, calor - Idoso; neuropatia autonômica (DM, Parkinson, amiloidose) Queda de PAS ≥ 20 / PAD ≥ 10 ou PAS < 90 em 3 min de ortostase reproduzindo sintomas	Durante esforço ou deitado Sem pródromo ou com palpitação súbita antes - Cardiopatia estrutural conhecida (IC, IAM prévio, FEVE baixa, valvopatia, cardiomiopatia hipertrófica, Chagas) História familiar de morte súbita $< 40-50$ anos, afogamento inexplicado, cardiomiopatia/canalopatia ECG anormal (seção 4) - Trauma facial/lesão grave (queda sem defesa) - Marca-passos/CDI; uso de antiarrítmico/QT-prolongador

2. Clínica — definição, diferenciais e estratificação de risco

2.1 Definições [ESC 2018]

Síncope = perda transitória de consciência por **hipoperfusão cerebral global**, de início rápido, curta duração ($< 1-2$ min, em geral < 20 s) e recuperação espontânea e completa. **Pré-síncope** = os pródromos sem perda de consciência (mesmo significado prognóstico). **Não é síncope** (outras perdas de consciência): crise epiléptica, TCE com concussão, intoxicação, hipoglicemia, hipóxia, AIT vertebrobasilar (raro — exige déficit focal), pseudossíncope psicogênica, cataplexia, queda mecânica sem perda de consciência.

2.2 Classificação etiológica

Grupo	Causas	Frequência no PS
Reflexa (neuromediada)	Vasovagal (emocional/ortostática); situacional (micção, tosse, defecação, deglutição, pós-exercício); síndrome do seio carotídeo (idoso, ao virar o pescoço/barbear); formas atípicas	~50-60%
Hipotensão ortostática	Medicamentosa (a mais comum); hipovolemia (sangramento, desidratação); falência autonômica primária (Parkinson, atrofia de múltiplos sistemas) ou secundária (DM, amiloidose, uremia, álcool)	~15%
Cardíaca	Arritmia: bradiarritmia (disfunção sinusal, BAV), taquiarritmia (TV, TSV rápida, FA pré-excitada), canalopatias (QT longo/curto, Brugada, TV catecolaminérgica), disfunção de MP/CDI, fármacos. Estrutural: estenose aórtica, cardiomiopatia hipertrófica, IAM/isquemia, TEP, dissecação de aorta, tamponamento, mixoma, hipertensão pulmonar, cardiopatia congênita, Chagas	~10-15% (maior em idosos e cardiopatas)
Inexplicada após avaliação inicial	—	~20-30% (a estratificação de risco orienta a conduta)

2.3 Diferenciais com armadilha

Condição	Pistas
Crise epiléptica	Aura, mordedura lateral da língua , cianose, abalos rítmicos prolongados (>30 s) desde o início, versão cefálica, confusão pós-ictal >5 min , incontinência (pouco específica), história de epilepsia. Atenção: síncope pode ter abalos breves (<15 s, arrítmicos, após a queda — "síncope convulsiva") — Protocolo 14
Pseudossíncope psicogênica	Episódios frequentes e prolongados (minutos), olhos fechados, sem trauma, sem alteração de PA/FC, jovem, contexto
AIT / AVC	Déficit focal, vertigem + diplopia + disartria (vertebrobasilar); perda de consciência isolada quase nunca é AIT — Protocolo 03
Hipoglicemia, intoxicação, hipóxia	Glicemia capilar; contexto; recuperação não espontânea
Hemorragia oculta (HDA, gravidez ectópica, aneurisma roto, dissecação)	Síncope + dor abdominal/torácica/lombar, melena, β-hCG, anemia — Protocolos 22/20/15
TEP	Síncope + dispneia/taquicardia/hipoxemia/TVP — Protocolo 19
Queda em idoso	Perguntar ativamente se houve perda de consciência (muitos não lembram); tratar como síncope se dúvida

2.4 Estratificação de risco [ESC 2018, Tabela 6; CSRS]

ALTO RISCO (qualquer um → observação monitorada / internação / transferência)	BAIXO RISCO (todos presentes → alta com orientação)
Evento: durante esforço ou deitado; sem pródromo ou palpitação súbita antes; dor torácica, dispneia, cefaleia intensa ou dor abdominal associadas; síncope em posição sentada sem gatilho História: cardiopatia estrutural/coronariana grave, IC, FEVE baixa, IAM prévio; história familiar de morte súbita jovem; síncope recorrente com trauma Exame: PAS <90 inexplicada; sangramento GI suspeito; bradicardia persistente <40 acordado; sopro sistólico não conhecido; sinais de IC ECG (seção 4): isquemia aguda; BAV Mobitz II ou 3º grau; FA lenta <40; bradicardia sinusal <40 ou pausas >3 s; bloqueio de ramo/bifascicular/QRS >120 ms; TV não sustentada; QT longo (>460) ou curto; pré-excitação; Brugada tipo 1; padrão de cardiomiopatia hipertrófica/displasia de VD; disfunção de MP; ondas Q Laboratório (se disponível): troponina elevada, BNP elevado, anemia nova, hipoxemia	• Típica de reflexa: pródromo claro, gatilho identificável (dor, calor, emoção, micção), após ficar em pé, longa história de episódios semelhantes desde jovem • Ou hipotensão ortostática documentada com causa reversível (fármaco, desidratação) corrigida • Sem cardiopatia estrutural, sem história familiar de morte súbita • Exame físico normal (PA, ausculta) • ECG normal • Sem lesão grave, sem episódios recorrentes recentes (<6 meses), sem comorbidade descompensada • Compreende as orientações e tem acompanhante/retorno

Canadian Syncope Risk Score (CSRS): predisposição a vasovagal (−1); cardiopatia (+1); PAS <90 ou >180 (+2); troponina >99º percentil (+2); eixo QRS anormal (+1); QRS >130 ms (+1); QTc >480 ms (+2); diagnóstico do PS: síncope vasovagal (−2) / cardíaca (+2). **≤0: muito baixo/baixo (0,4-1,2% de evento grave em 30 dias) → alta; 1-3: médio (3-8%) → observação/investigação; ≥4: alto/muito alto (12-50%) → internar/transferir.** Regras como San Francisco/OESIL têm menor acurácia; o julgamento clínico estruturado com os critérios ESC é o padrão.

3. Exame físico — o que procurar

Item	Achado / significado
PA e FC deitado e após 1 e 3 min em pé (ortostática ativa)	Queda PAS ≥ 20 / PAD ≥ 10 ou PAS < 90 com sintomas = hipotensão ortostática; FC que sobe > 30 sem queda de PA = taquicardia postural (POTS); fazer em todos
PA nos dois braços	Assimetria → dissecação
Ausculta cardíaca	Sopro sistólico ejetivo (estenose aórtica — síncope de esforço; cardiomiopatia hipertrófica — aumenta com Valsalva), B3/B4, ritmo irregular, bradicardia
Estase jugular, edema, estertores	IC / TEP / tamponamento
Pulsos e perfusão	Choque oculto; TEP
Abdome, toque retal se indicado	Massa pulsátil (aneurisma), dor (ectópica, isquemia), melena (HDA)
Neurológico	Déficit focal (AVC), confusão persistente (pós-ictal), mordedura de língua
Trauma	Lesões faciais/occipitais sem defesa = perda súbita sem pródromo (sugere cardíaca); fraturas (idoso)
Massagem do seio carotídeo	Só > 40 anos, sem sopro/AVC/AIT recente, com monitor: 5–10 s de cada lado — pausa ≥ 3 s ou queda PAS ≥ 50 com reprodução dos sintomas = síndrome do seio carotídeo (ESC 2018)
Pele/mucosas	Palidez (anemia), desidratação, sinais de uso de drogas

4. Propedêutica armada — o ECG é o exame; o resto é dirigido [ESC 2018; ACC 2017]

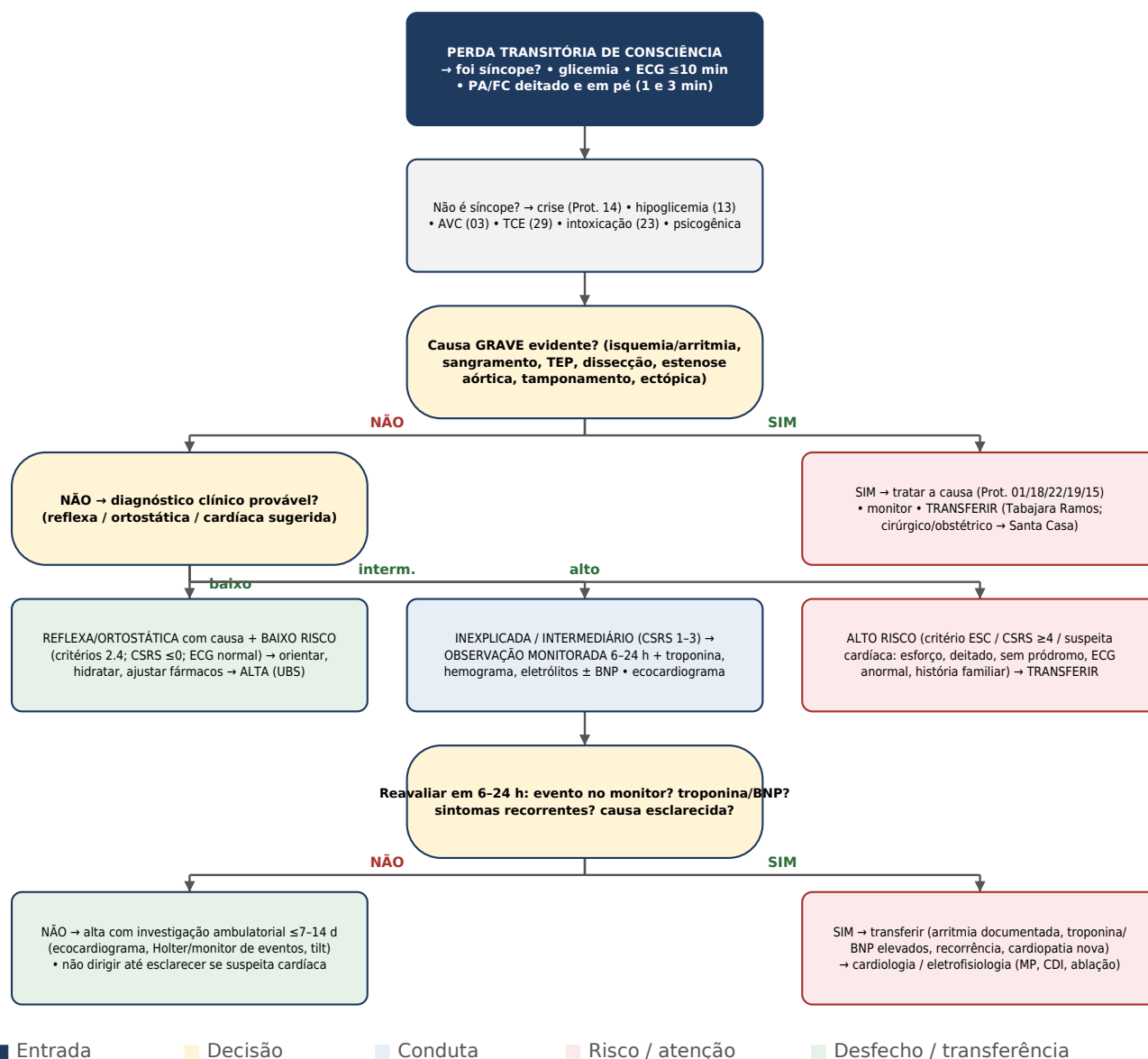
Exame	O que procurar / para que serve	Quando
ECG 12 derivações	Ver lista da seção 2.4: bradi/BAV, bloqueios, QT longo/curto, pré-excitação (delta), Brugada (supra em V1-V2 tipo 1 — repetir com V1-V2 no 2º EIC), HVE/ondas Q/T invertidas em V1-V3 (displasia de VD), TV, isquemia; ler o QTc e o eixo	Todos, em ≤10 min ; repetir se sintomas
Glicemia capilar	Hipoglicemia (não é síncope, mas mimetiza)	Todos
Hemograma	Anemia → sangramento oculto	Todos os de risco intermediário/alto; suspeita de sangramento
Eletrólitos, creatinina, glicemia	HipoK/hipoMg (QT), uremia, desidratação	Idoso, diurético, vômitos, ECG alterado
Troponina	Isquemia; entra no CSRS; elevação = alto risco	Dor torácica, ECG alterado, cardiopatia, idoso, CSRS
BNP/NT-proBNP	IC/cardiopatia estrutural oculta; BASEL IX: valor prognóstico	Se disponível, risco intermediário [VERIFICAR]
β-hCG	Gravidez ectópica rota	Toda mulher em idade fértil com síncope
D-dímero / angio-TC	TEP (probabilidade — Protocolo 19)	Dispneia, taquicardia, hipoxemia, TVP, fatores de risco
Monitorização contínua no PS (≥6 h; 24 h se alto risco)	Arritmia intermitente; pausas; TV	Risco intermediário/alto enquanto aguarda transferência/decisão
Ecocardiograma	Estenose aórtica, cardiomiopatia, FEVE, hipertensão pulmonar, tamponamento; POCUS inicial no PS se disponível	Cardiopatia suspeita, sopro, ECG anormal, síncope de esforço — referência
TC de crânio	Não de rotina (rendimento <1% na síncope pura); só com déficit focal, TCE relevante, cefaleia, anticoagulado, confusão persistente	Selecionado
EEG, Doppler de carótidas	Não na síncope típica (sem valor); EEG só se suspeita de crise	Raramente
Holter/monitor de eventos/loop implantável, teste de inclinação, estudo eletrofisiológico	Investigação de síncope recorrente inexplicada / suspeita arritmica	Ambulatorial via cardiologia (Tabajara Ramos)

5. Fisiopatologia

A consciência depende de um fluxo cerebral sustentado; uma interrupção de 6–8 s ou queda da PAS a ~50–60 mmHg no nível cerebral produz perda de consciência. Três mecanismos levam a isso. Na **síncope reflexa**, um gatilho (dor, emoção, ortostase prolongada, distensão de víscera) dispara um reflexo vagal desproporcional: vasodilatação (componente vasodepressor) e/ou bradicardia/assistolia (cardioinibitório) — precedidos por ativação simpática compensatória que gera os pródromos (sudorese, náusea, palidez); a recuperação é rápida porque o reflexo cessa ao deitar. Na **hipotensão ortostática**, a falha do ajuste vasoconstritor ao ficar em pé (fármacos, hipovolemia, disautonomia) deixa 500–1.000 mL de sangue represados nas pernas e no esplâncnico; o idoso, com barorreflexo lento e rigidez arterial, é o mais vulnerável. Na **síncope cardíaca**, o débito cai abruptamente por arritmia (FC muito baixa ou muito alta que não enche o ventrículo) ou por obstrução mecânica (estenose aórtica, cardiomiopatia hipertrófica, TEP maciço, tamponamento) — tipicamente sem pródromo ou durante esforço, quando a demanda excede a capacidade de aumentar o débito. As canalopatias (QT longo, Brugada) produzem TV polimórfica autolimitada em corações estruturalmente normais: o ECG entre os episódios é o único indício. Os abalos mioclônicos breves da síncope resultam da anóxia cortical transitória e não de descarga epiléptica — daí serem curtos, arrítmicos e posteriores à queda.

6. Fluxo de atendimento [ESC 2018, Figura 6, adaptado]

Três perguntas: **foi síncope?** → **há causa grave evidente?** → **qual o risco?** O ECG lido com atenção (QTc, eixo, pré-excitação, Brugada, bloqueios) e a PA ortostática valem mais do que qualquer exame de imagem.



6.1 Metas de tempo

Intervalo	Meta
Chegada → ECG 12 derivações + glicemia + PA ortostática	≤10-30 min
Chegada → classificação de risco documentada (ESC/CSRS)	≤1 h
Risco intermediário → decisão (alta com investigação x transferência)	≤6-24 h de observação monitorada
Alto risco → regulação para cardiologia/UTI	Imediata ao classificar; monitor e pás adesivas disponíveis enquanto aguarda

7. Conduta por causa

7.1 Síncope reflexa (vasovagal/situacional) [ESC 2018; ACC 2017]

Medida	Detalhe
Educação e tranquilização	Explicar a benignidade e o mecanismo; identificar e evitar gatilhos (calor, longa ortostase, desidratação, álcool, dor); reconhecer pródromos
Manobras de contrapressão	Ao sentir pródrómo: cruzar as pernas e contrair, apertar as mãos uma contra a outra, agachar/deitar com pernas elevadas — reduzem recorrência (ensinar no PS)
Hidratação e sal	2–3 L/dia e ingestão liberal de sal (se sem HAS/IC); meias elásticas em ortostase prolongada
Fármacos	Não de rotina. Recorrente e incapacitante (>40 anos, sem HAS): midodrina 2,5–10 mg 3×/dia ou fludrocortisona 0,1–0,2 mg/dia (jovens) — decisão ambulatorial (cardiologia); betabloqueador não é eficaz
Marca-passos	Só em ≥40 anos com pausas espontâneas documentadas ≥3 s sintomáticas ou ≥6 s assintomáticas (loop implantável) ou seio carotídeo cardioinibitório — referência
Situacional	Micção: urinar sentado; tosse: tratar a tosse; deglutição: investigar esôfago; pós-exercício: desaquecer gradualmente

7.2 Hipotensão ortostática

Medida	Detalhe
Revisar fármacos (a intervenção mais eficaz)	Reduzir/suspender diuréticos, alfa-bloqueadores (doxazosina, tansulosina), vasodilatadores, nitratos, tricíclicos/antipsicóticos, levodopa em excesso; em idoso hipertenso, aceitar PA mais alta em pé (alvo funcional, não numérico) — DBHA 2025
Volume	Corrigir desidratação/sangramento (SF 0,9% 500–1.000 mL se hipovolemia); tratar diarreia/vômitos
Medidas físicas	Levantar devagar em etapas; cabeceira elevada 10–20° à noite; meias de compressão até a cintura/cinta abdominal; contrapressão; refeições pequenas e frequentes (hipotensão pós-prandial); evitar calor e álcool
Fármacos (disautonomia)	Midodrina 2,5–10 mg 3×/dia (não à noite) ou fludrocortisona 0,1–0,3 mg/dia; droxidopa/piridostigmina na referência — não iniciar no PS sem plano de seguimento
Investigar a causa	DM (neuropatia), Parkinson, amiloidose, DRC, deficiência de B12, álcool — encaminhar

7.3 Síncope cardíaca — o que fazer no PS enquanto transfere

Causa	Conduta imediata	Destino
Bradiarritmia (BAV Mobitz II/3º grau, disfunção sinusal, pausas)	Monitor; atropina/MP transcutâneo se sintomática (Protocolo 18); suspender BB/BCC/digoxina	MP definitivo — Tabajara Ramos
Taquiarritmia (TV, TSV rápida, FA pré-excitada)	Protocolo 18; K/Mg; ECG pós-reversão	Eletrofisiologia/CDI
QT longo (>480–500 ms) / torsades	Suspender QT-prolongadores (macrolídeos, quinolonas, antipsicóticos, ondansetrona, antiarrítmicos), K >4,5, Mg >2; monitor	Cardiologia (canalopatia: BB, CDI)
Brugada tipo 1 com síncope	Evitar febre alta (antitérmico), evitar fármacos (brugadadrugs.org); monitor	CDI — referência
Pré-excitação (WPW) com síncope	Sem BB/BCC/digoxina; monitor	Ablação
Estenose aórtica / cardiomiopatia hipertrófica	Evitar vasodilatadores, diuréticos e desidratação; repouso; sem esforço	Cirurgia/TAVI; CDI — referência
Isquemia / IAM	Protocolo 01	Hemodinâmica — Tabajara Ramos
TEP / dissecação / tamponamento	Protocolos 19/15; POCUS	UTI / cirurgia cardiovascular
Disfunção de MP/CDI	ECG (falha de captura/sensing); ímã se choques inapropriados	Serviço de MP

7.4 Alta — pacote obrigatório

- Diagnóstico provável e risco escritos no prontuário (critérios ESC/CSRS); ECG laudado (QTc numérico).
- Orientações por escrito: gatilhos, contrapressão, hidratação, levantar devagar, o que fazer no pródromo; sinais de retorno imediato (síncope de esforço/deitado, palpitação antes, dor torácica, dispneia, trauma, recorrência).
- **Direção veicular:** reflexa isolada — sem restrição; reflexa recorrente grave, inexplicada com suspeita cardíaca ou arritmia — não dirigir até avaliação/tratamento (CONTRAN/ESC); documentar a orientação; ocupações de risco (altura, máquinas).
- Ajuste de medicações causadoras (com receita) e comunicação à UBS; encaminhamento a cardiologia (ecocardiograma/Holter) em $\leq 7-14$ dias quando risco intermediário ou recorrente; idoso com queda: avaliação de fragilidade/osteoporose na APS.

8. Como conduzir o caso — transferência, permanência e indicadores

8.1 Quem transferir / internar

Situação	Urgência	Destino
Causa grave identificada (arritmia, isquemia, sangramento, TEP, dissecção, tamponamento, estenose aórtica sintomática)	Imediata	Conforme causa — Tabajara Ramos (UTI/cardiologia/hemodinâmica) ou Santa Casa (cirúrgico/obstétrico)
Alto risco (critério ESC / CSRS ≥ 4) sem diagnóstico	Mesmo dia, monitorado	Cardiologia com ecocardiograma/monitor — Tabajara Ramos
Risco intermediário sem leito de observação monitorada 6-24 h no PS	Mesmo dia	Unidade de observação / enfermaria
Risco intermediário com observação completa sem eventos	Alta com investigação ambulatorial $\leq 7-14$ dias	Cardiologia ambulatorial
Baixo risco	Alta	UBS
Idoso com síncope + trauma/fratura; síncope recorrente com lesão	Mesmo dia	Ortopedia (Santa Casa) + investigação

8.2 Transporte e documentação

- Monitor e pás adesivas em alto risco; decúbito; acesso.
- Relatório: descrição do episódio (testemunha), pródromo, posição/atividade, recuperação, ECG (anexar), PA ortostática, exames, escore de risco, medicações (especialmente as suspensas), história familiar, diagnóstico presumido.
- Regulação: CROSS-SP / SAMU 192.

8.3 Indicadores de qualidade (auditoria mensal)

Indicador	Meta
% de síncope com ECG em ≤ 10 min com QTc e eixo registrados	$\geq 95\%$
% com PA ortostática (1 e 3 min) documentada	$\geq 90\%$
% com classificação de risco (ESC/CSRS) e diagnóstico presumido documentados	$\geq 90\%$
% de TC de crânio em síncope sem déficit/TCE/anticoagulação (evento — baixo valor)	Registrar; reduzir
% de baixo risco com alta e orientação escrita; % de alto risco transferidos/monitorados	$\geq 90\%$ / 100%
% de mulheres em idade fértil com β -hCG	100%
Retorno em 30 dias por evento grave (arritmia, morte, IAM) após alta do PS	Registrar; revisar cada caso

9. Divergências entre fontes e itens a verificar antes da aprovação

Tema	Posição declarada
Escore x critérios	ESC 2018: critérios de alto/baixo risco + julgamento; ACC 2017: idem, escores como apoio; CSRS validado (2020) para eventos em 30 dias. Adotados os critérios ESC com CSRS como apoio numérico
Troponina/BNP	BASEL IX e CSRS: valor prognóstico; ESC: seletivo. Adotado: em risco intermediário/alto e no CSRS [VERIFICAR disponibilidade]
Tempo de observação	ESC/ACC: unidade de observação de síncope 6-24 h reduz internação; sem estrutura, transferir o intermediário. Adotado
Massagem do seio carotídeo	ESC 2018: em >40 anos; ACC: semelhante; risco de AVC em ateromatose — só com monitor e sem sopro/AVC prévio
Direção veicular	ESC 2018/CONTRAN: restrição conforme causa; documentar orientação — não há norma nacional única para síncope [VERIFICAR CFM/CONTRAN]
Diretriz brasileira de síncope	SBC/SOBRAC — edição e vigência a confirmar [VERIFICAR]
Midodrina/fludrocortisona	Evidência modesta (POST 2/COMPASS); iniciar só com seguimento; disponibilidade SUS [VERIFICAR]
Ecocardiograma/Holter/tilt na referência	Fluxo ambulatorial e prazo definem se a alta do intermediário é segura [VERIFICAR/PACTUAR com Tabajara Ramos]

10. Referências

- Brignole M, Moya A, de Lange FJ, et al. 2018 ESC Guidelines for the diagnosis and management of syncope. Eur Heart J 2018;39(21):1883-1948.
- Shen WK, Sheldon RS, Benditt DG, et al. 2017 ACC/AHA/HRS Guideline for the evaluation and management of patients with syncope. Circulation 2017;136(5):e60-e122.
- Thiruganasambandamoorthy V, Kwong K, Wells GA, et al. Development of the Canadian Syncope Risk Score to predict serious adverse events after emergency department assessment of syncope. CMAJ 2016;188(12):E289-E298.
- Thiruganasambandamoorthy V, Sivilotti MLA, Le Sage N, et al. Multicenter emergency department validation of the Canadian Syncope Risk Score. JAMA Intern Med 2020;180(5):737-744.
- du Fay de Lavallaz J, Badertscher P, Nestelberger T, et al. B-type natriuretic peptides and cardiac troponins for diagnosis and risk-stratification of syncope (BASEL IX). Circulation 2019;139:2403-2418.
- Sociedade Brasileira de Cardiologia / Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Diretrizes brasileiras de síncope (edição vigente) [VERIFICAR]. Brandão AA, et al. Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial – 2025 (hipotensão ortostática no idoso). Arq Bras Cardiol 2025;122(9):e20250624.
- Sheldon R, et al. Fludrocortisone for the prevention of vasovagal syncope (POST 2). J Am Coll Cardiol 2016;68:1-9.
- Sheldon R, et al. Midodrine for the prevention of vasovagal syncope (POST 4). Ann Intern Med 2021;174:1349-1356.
- Velasco IT, et al. (eds.). *Medicina de Emergência: abordagem prática — HC-FMUSP*. Manole, edição vigente — capítulo de síncope (página não conferida).

Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986

Responsável técnico pela elaboração